

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA DE LA OMS (WHOQOL-BREF)

Eje IV: Calidad de Vida Global • Medida Transcultural de 4 Dominios de la OMS

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Calidad de Vida de la OMS - Versión Breve (WHOQOL-BREF).
Nombre Original	World Health Organization Quality of Life - BREF (WHOQOL Group, 1998).
Autores Originales	Organización Mundial de la Salud (Grupo WHOQOL / OMS Ginebra).
Adaptación Hispana	Ramona Lucas-Carrasco (2001, 2011); Centro WHOQOL Barcelona / Universidad de Barcelona.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Calidad de Vida. Percepción multidimensional del bienestar y contexto vital.
Tipo de Instrumento	Cuestionario de autoinforme transcultural breve de 26 reactivos.
Formato de Respuesta	Escala Likert de 5 puntos con descriptores semánticos adaptados a cada reactivo.
Población y Rango	Adultos (≥ 18 años) en población general, enfermos crónicos o pacientes psiquiátricos.
Tiempo de Administración	8 a 12 minutos de cumplimentación autónoma.
Régimen de Licencia	Distribución oficial gratuita por la OMS para fines clínicos y de investigación.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO TRANSCULTURAL DE CALIDAD DE VIDA

El **WHOQOL-BREF** deriva del WHOQOL-100 desarrollado en 15 centros internacionales simultáneos bajo la égida de la OMS:

- Definición Contextual Subjetiva:** La calidad de vida se define como **la percepción que un individuo tiene de su posición en la vida dentro del contexto cultural y sistema de valores en que vive, y en relación con sus metas, expectativas, normas y preocupaciones.**
- Superación del Sesgo Occidental:** Se elaboró mediante consultas cualitativas mundiales, garantizando que los dominios evaluados sean relevantes en diversas culturas, estratos socioeconómicos y sistemas de creencias.
- Cuatro Macro-Dominios Vitales:** Agrupa de forma parsimoniosa las dimensiones de salud física, esfera psicológica interna, redes de soporte social y el entorno ambiental material.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS (26 ÍTEMS)

Dominio / Escala	Nº Ítems	Contenido y Facetas Evaluadas en el WHOQOL-BREF
Ítems Generales Globales	Ítems 1 y 2	Percepción global de la calidad de vida (ítem 1) y satisfacción con la propia salud (ítem 2).
1. Salud Física	7 ítems	Dolor y molestias, energía y fatiga, sueño, movilidad, actividades diarias, fármacos, trabajo.
2. Salud Psicológica	6 ítems	Sentimientos positivos, espiritualidad/creencias, cognición, autoestima, imagen corporal, disforia.
3. Relaciones Sociales	3 ítems	Relaciones personales/amistades, apoyo social recibido y satisfacción con la vida sexual.
4. Medio Ambiente	8 ítems	Seguridad física, entorno físico, recursos económicos, información, ocio, hogar, sanidad, transporte.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La validación española de Lucas-Carrasco (2001, 2011; $N = 780$ pacientes clínicos y controles comunitarios) evidencia excelentes propiedades:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna	Alfa de Cronbach = 0.77 - 0.88	Buena fiabilidad en Salud Física (0.84), Psicológica (0.78), Social (0.77) y Ambiente (0.81).
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.78 - 0.87	Alta reproducibilidad temporal a 2 semanas en sujetos en fase de estabilidad clínica.
Validez Discriminante	$t = 9.8, p < 0.001$	Diferenciación estadísticamente significativa entre población sana y grupos de enfermos.
Validez Concurrente	$r = 0.68 - 0.75$ (SF-36)	Fuerte convergencia con las dimensiones físicas y mentales homólogas del SF-36.
Sensibilidad Clínica	Tamaño efecto $d = 0.70$	Sensible a la mejoría funcional tras intervenciones terapéuticas multidisciplinares.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN, INVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN A MÉTRICA 0-100

- **Inversión Previa Obligatoria:** Invertir los valores de los reactivos **3** (dolor físico), **4** (dependencia médica) y **26** (sentimientos negativos):

$$\text{Valor Invertido} = 6 - \text{Valor Original} \quad (1 \rightarrow 5, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 2, 5 \rightarrow 1)$$

- **Cálculo de la Puntuación Media por Dominio:** Se promedian los ítems de cada dominio (rango 1.00 a 5.00 puntos).
- **Transformación Lineal a Escala 0-100 (Estándar OMS):** Se normaliza a una métrica porcentual de 0 a 100 puntos:

$$\text{Puntuación Dominio (0 a 100)} = \left(\frac{\text{Media del Dominio} - 1}{4} \right) \times 100$$

- **Direccionalidad:** A mayor puntuación (0 a 100), mayor calidad de vida percibida en el dominio evaluado.

6. BAREMOS NORMATIVOS POBLACIONALES Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntos 0-100	Media Directa	Significación Clínica y Percepción Vital (Lucas-Carrasco)
Buena / Óptima	70 a 100 pts	3.80 a 5.00	Calidad de vida satisfactoria; media comunitaria española (promedio = 68-75 pts).
Intermedia Alerta	/ 50 a 69 pts	3.00 a 3.79	Zonas de fricción o quejas moderadas en el área evaluada; apoyo necesario.
Deteriorada Mala	/ 30 a 49 pts	2.20 a 2.99	Afectación clínica significativa; limitaciones notables en autonomía y bienestar.
Muy Mala Crítica	/ < 30 pts	< 2.20	Colapso severo de la calidad de vida en el dominio; sufrimiento existencial marcado.

CRITERIO DE VULNERABILIDAD SECTORIAL (DOMINIO < 50 PUNTOS):

Cualquier dominio con puntuación transformada inferior a **50 puntos** alerta sobre un colapso sectorial específico que puede permanecer encubierto si solo se observa la puntuación general (p. ej., buen estado físico con pésimo entorno ambiental por pobreza o violencia comunitaria).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN CLÍNICA CON WHOQOL-BREF

PROTOCOLO DE ACCIÓN CLÍNICA BASADO EN LOS 4 DOMINIOS:

- **Paso 1 (Línea Base en Consulta Médica o Psicológica):** Administrar WHOQOL-BREF y trazar el perfil de los 4 dominios en escala 0-100.
- **Paso 2 (Intervenciones Dirigidas por Dominio):**
 - *Salud Física* < 50: Optimizar farmacoterapia, higiene de sueño y rehabilitación fisioterápica.
 - *Salud Psicológica* < 50: Derivar a psicoterapia (TCC/Mindfulness) para manejo de afectos negativos y autoestima.
 - *Relaciones Sociales* < 50: Focalizar en asertividad, resolución de conflictos diádicos y red de apoyo mutuo.
 - *Medio Ambiente* < 50: Coordinar con Trabajo Social municipal para abordar barreras económicas o de vivienda.
- **Paso 3 (Monitorización Semestral):** Un incremento de ≥ 8 puntos en un dominio representa una ganancia clínica relevante.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN INTEGRAL EN ENFERMEDAD CRÓNICA (EPOC Y ANSIEDAD)

Identificación: Varón de 63 años, jubilado anticipado por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) estadio III, remitido por neumología por ataques de pánico secundarios a disnea y aislamiento domiciliario prolongado.

Perfil Inicial WHOQOL-BREF (Métrica 0-100):

- **Ítems Generales:** Calidad de vida global = 2/5 (Mala); Satisfacción con la salud = 1/5 (Muy insatisfecho).
- **Dominio 1 (Salud Física):** **28.6 / 100 (Muy Mala).** Afectación severa en energía, sueño y dependencia de inhaladores.
- **Dominio 2 (Salud Psicológica):** **41.7 / 100 (Deteriorada).** Ansiedad anticipatoria ante el ahogo y baja autoestima.
- **Dominio 3 (Relaciones Sociales):** **58.3 / 100 (Intermedia).** Soporte conyugal adecuado pero nula interacción externa.
- **Dominio 4 (Medio Ambiente):** **53.1 / 100 (Intermedia).** Vivienda con barreras arquitectónicas (sin ascensor).

Tratamiento Multidisciplinar: Rehabilitación respiratoria estructurada, psicoterapia cognitivo-conductual con respiración diafragmática pausada y reestructuración de catastrofismo, junto con tramitación de cambio de domicilio a planta baja.

Reevaluación a los 6 Meses: Salud Física ascendió a **57.1 / 100**; Salud Psicológica a **66.7 / 100**; Relaciones Sociales a **75.0 / 100**; y Medio Ambiente a **71.9 / 100**. El paciente recuperó paseos diarios y redujo a cero las visitas a urgencias.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ÍTEM 26 Y DISFORIA SEVERA:

Una respuesta de "Siempre" en el ítem 26 (desesperanza/ansiedad) requiere valoración psiquiátrica urgente para descartar riesgo de suicidio inminente.

NO COMPARAR SIN BAREMO LOCAL:

El dominio de Medio Ambiente es altamente sensible al contexto socioeconómico local; no contrastar poblaciones rurales y urbanas sin ajustar baremos.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. The WHOQOL Group. (1998). Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. *Psychological Medicine*, 28(3), 551-558.
2. Lucas-Carrasco, R. (2001). Versión española del WHOQOL: Cuestionario de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud. *Ergón*.
3. Lucas-Carrasco, R., Skevington, S. M., Gómez-Benito, J., et al. (2011). Using the WHOQOL-BREF in persons with dementia: A validation study. *Alzheimer Disease and Associated Disorders*, 25(4), 345-351.
4. Skevington, S. M., Lotfy, M., & O'Connell, K. A. (2004). The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: Psychometric properties and results of the international field trial. *Quality of Life Research*, 13(2), 299-310.